

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	頭頸部腫瘤-鼻咽癌 Nasopharyngeal Carcinoma；NPC				
編號	A31000-Q03-W-K05	制定者	N17 陳瑩婕	公布日期	98 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 3.7 版/9 頁	審查者	曾翊婕	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解鼻咽癌的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，增加臨床照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

鼻咽癌是第二常見的頭頸部惡性腫瘤且為癌症死亡原因的第十九位(衛生福利部統計處，2025)。好發於 40-50 歲之間，男性發病率為女性 3 倍，其發生於鼻部與咽部交會處，即鼻部的後方，咽部的頂端。一般認為與鼻咽癌有密切關聯的因素為：種族遺傳因素、環境致癌因素（如居家或工作環境不良或常易吸入刺激性氣體如甲醛、煙、粉塵、木屑等）、飲食習慣因素（如抽菸、喝酒或常食用醃製品如鹹魚、鹹菜等）。另外，在大部分鼻咽癌細胞中可以檢測到 EB 病毒的基因表現，因此 EB 病毒也被認為與鼻咽癌有密切關聯。

（二）症狀

鼻咽癌早期症狀不明顯，常見的症狀有：頸部淋巴結腫大（通常無痛性，摸起來較硬，是最容易被發現的徵兆）、鼻涕或痰中帶血、鼻塞、單側聽力障礙或耳悶塞感、頭痛、臉麻、複視等。

（三）常見檢查

主題名稱	頭頸部腫瘤-鼻咽癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K05	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	2/9

1. 血清抗 EB 病毒抗體測定。
2. 支氣管鏡檢查(Bronchoscope)。
3. 鼻咽切片(Nasopharyngeal biopsy)。
4. 腦部電腦斷層(Brain Computerized Tomography, Brain CT)。
5. 正子放射斷層攝影(Positron Emission Tomography, PET)。
6. 核磁共振(Magnetic resonance imaging, MRI)。

(四) 常見治療

鼻咽癌最新的治療標準，以 T(腫瘤大小)、N(頸部淋巴結)、M(遠端轉移)分期決定治療方針，若分期為 T1N0M0 以放射線治療為主，若分期為 N>0 或 M>0 時，極容易發生頸部淋巴腺和遠隔轉移，為了增加腫瘤控制率，降低遠端轉移，除放射線治療，尚需搭配輔助性化學治療，即同步化學放射線治療(Concurrent Chemoradiotherapy, CCRT)。放射線治療劑量一般建議為 66-70 格雷 (Gray，簡稱 Gy)，而較常輔助使用的化學治療藥物是順鉑(Cisplatin)和 5-氟尿嘧啶(5-Fluorouracil)。針對復發性鼻咽癌的治療主要是以內視鏡鼻咽切除手術與再次接受放射線治療為主。

(五) 護理問題

1. 易感染／與第二道防線不完善-腫瘤傷口有關。
2. 呼吸道清除功能不良／與鼻腔分泌物增加有關。
3. 尋求（特定的）健康協助／與缺乏對疾病資訊之來源有關。
4. 疼痛不適／與鼻咽癌疾病本身有關。
5. 身體心像不一致／與 CCRT 治療副作用造成身體外觀改變有關。

(六) 護理措施

1. 易感染／與第二道防線不完善-腫瘤傷口有關
 - (1) 監測生命徵象。
 - (2) 監測全血球計數並報告 WBC 異常現象或相關血液檢查值、白蛋白值。
 - (3) 紀錄及檢查傷口滲出液顏色、氣味、濃稠度、癒合情況。

主題名稱	頭頸部腫瘤-鼻咽癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K05	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	3/9

- (4)觀察傷口敷料外觀。
 - (5)治療前後洗手。
 - (6)無菌技術收集標本培養以監測感染存在。
 - (7)依醫囑正確使用冰或熱敷。
 - (8)依醫囑按時給予抗生素、抗癌藥物、支氣管擴張劑、祛痰劑。
 - (9)依醫囑以無菌技術換藥。
 - (10)教導保持傷口乾燥及清潔且避免壓迫傷口。
 - (11)教導感染的危險因子及預防感染的重要性。
 - (12)指導炎症症狀及徵象。
 - (13)教導選擇高蛋白、高維生素飲食，以促進傷口的修復再生。
 - (14)宣導抽煙、喝酒害處。
 - (15)適量輸液或水分補充。
 - (16)教導執行口腔護理。
 - (17)依醫囑按時給予維他命或營養素。
 - (18)保持乾淨的環境，確保良好的換氣和表面清潔。
 - (19)盡量減少住院天數以預防院內感染。
- 2.呼吸道清除功能不良／與鼻腔分泌物增加有關
- (1)評估呼吸狀況，紀錄呼吸頻率和節律、呼吸音、咳嗽和分泌物的特性。
 - (2)聽診呼吸音，評估並記錄分泌物的量、顏色、濃稠度。
 - (3)聽診呼吸音，觀察並記錄呼吸型態、次數、發紺情形、皮膚顏色（suction 後）。
 - (4)監測脈搏血氧定量法和動脈血液氣體分析值。
 - (5)依醫囑送檢體做培養、細胞學和敏感試驗。
 - (6)協助病人採高坐臥姿；至少每 2 小時翻身一次以移動分泌物。
 - (7)教導病人深呼吸後有效咳嗽。
 - (8)必要時，抽吸呼吸道，抽吸時間不超過 15 秒。

主題名稱	頭頸部腫瘤-鼻咽癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K05	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	4/9

- (9)抽吸前後，先給予氧氣或鼓勵深呼吸，使肺過度充氣。
 - (10)依醫囑執行胸腔物理治療如：叩擊、姿位引流等。
 - (11)提供病人足夠氧合狀態：鼓勵經口攝取液體或依醫囑維持靜脈輸液。
 - (12)依醫囑給予濕潤的氧氣，尤其當病人身上有人工氣管時。
 - (13)依醫囑給予藥物如：支氣管擴張劑、類固醇、祛痰劑和抗生素。
 - (14)紀錄護理措施的效果。
 - (15)床旁隨時備妥抽痰器。
 - (16)抽痰前後給給予 100%O₂，以提高含氧量。
 - (17)以無菌技術抽痰，動作宜輕柔，避免黏膜損傷。壓力維持在 100-120mmHg，抽吸時間不超過 15 秒。
 - (18)視病人需要給予姿位引流，每天 4 次，每次 15 分鐘。
 - (19)依醫囑給予噴霧治療、叩擊、抽痰。
 - (20)採分段餵食，並在餵食後予以排氣，抬高床頭 45-60 度，並留意有無嘔吐。
 - (21)如呼吸過速，勿由口進食。
 - (22)依醫囑給予靜脈補充體液，並維持適當的滴數。
 - (23)依醫囑給予藥物，以減少氣管阻塞並評估效果及副作用。
- 3.尋求（特定的）健康協助／與缺乏對疾病資訊之來源有關
- (1)評估病人及家屬認知及對手術（檢查）的瞭解程度。
 - (2)告知手術（檢查）的目的、過程及可能造成身體心像的改變。
 - (3)提供衛教單張並予指導衛教。
 - (4)鼓勵病人發問及解答其疑問。
 - (5)介紹成功病人，減輕其焦慮並給予心理支持。
 - (6)配合完成手術（檢查）前的各項準備及護理。
 - (7)給予手術前指導如：告知開始禁食時間及禁食原因、重要性。
 - (8)鼓勵早期下床活動。
 - (9)鼓勵深呼吸、咳嗽、翻身運動。

主題名稱	頭頸部腫瘤-鼻咽癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K05	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	5/9

(10)衛教若有傷口感染及異常徵兆（紅、腫、熱、痛、滲液多、滲血）請通知護理人員。

(11)維持管路暢通，並注意引流液性質、量及顏色。

(12)給予檢查後指導如：告知進食時間。

(13)教導多喝開水。

(14)依醫囑予砂袋加壓_____（時間）。

(15)依醫囑予平躺_____（時間）。

(16)若有任何不適或異常，請通知護理人員。

4.疼痛不適／與鼻咽癌疾病本身有關

(1)評估病人的疼痛程度及特徵。

(2)評估疼痛加劇的原因。

(3)減少或排除疼痛的因素。

(4)教導利用枕頭或毛毯支持疼痛部位。

(5)教導放鬆技巧如：深呼吸、背部按摩、冥想。

(6)予轉移注意力如：音樂、書籍、聊天。

(7)依醫囑予物理治療如：熱敷、冷敷。

(8)在病人選擇疼痛控制方法時，給予支持與指導。

(9)教導咳嗽或改變姿勢時，以手或束腹帶固定傷口。

(10)與病人及家屬共同討論可控制引發疼痛的因素之方法。

(11)避免腹部用力如：哭鬧蹲姿、用力解便、咳嗽等，預防傷口疼痛或裂開。

(12)依醫囑給予止痛劑。

(13)評值疼痛控制技巧的效果。

(14)評估藥物的效果及副作用。

(15)衛教病人咳嗽時可按壓傷口，避免牽扯疼痛。

(16)鼓勵家屬多予陪伴。

(17)安排合適姿勢。

主題名稱	頭頸部腫瘤-鼻咽癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K05	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	6/9

(18)教導病人避免突然的移動或負重。

5.身體心像不一致／與 CCRT 治療副作用造成身體外觀改變有關

(1) 每天執行照護外，安排 10-15 分鐘傾聽陪伴病人，引導病人說出治療副作用不適的感受，同理其對外在的重視，病人表達感受時，採取主動傾聽、接受及不批評的態度，在負向情緒出現時予拍肩、握手接觸提供陪伴。

(2) 告知口腔黏膜炎、掉頭髮及皮膚炎等副作用是可回復的，並鼓勵其參與共同照護：

A. 可選擇喜愛的棉質睡衣替換，衣著以寬鬆、柔軟為主，避免有領衣物摩擦皮膚。

B. 針對掉髮副作用，告知可配戴喜歡的頭巾，或以常用髮束盤紮，每日輕柔整理。

(3) 鼓勵家屬帶病人外出活動，當病人願意走出病室時，給予微笑口頭鼓勵，如：有進步、加油等話語。

(七) 衛教指導

- 1.植入式中心靜脈導管照護。
- 2.快樂面對化療。
- 3.化學治療用藥安全。
- 4.化學藥物衛教。
- 5.化學治療後的噁心嘔吐。
- 6.放射線治療的照護。
- 7.口腔黏膜炎的照護。
- 8.成人拍痰須知。
- 9.癌症病人的飲食。
- 10.癌症疼痛。
- 11.正確使用嗎啡類止痛藥。
- 12.腫瘤病人居家照護手冊。

主題名稱	頭頸部腫瘤-鼻咽癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K05	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	7/9

13. 安寧導覽。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 蘇慈棉、陳幼貴(2020)．運用 Watson 關懷理論照護一位鼻咽癌病人之護理經驗．腫瘤護理雜誌，20(1)，51-62。
- (二) 黃聖凱、沈炳宏(2022)．內視鏡鼻咽切除術．台灣耳鼻喉頭頸外科雜誌，56，87-92。
- (三) 廖怡雯、黃惠珠、白藍妮、紀夙芬、葉淑玲(2023)．鼻咽癌病人接受同步化學治療及質子放射線治療之護理經驗．志為護理，22(6)，88-98。
- (四) 衛生福利部統計處(2025，6 月 12 日)．112 年死因統計年報。

<https://dep.mohw.gov.tw/DOS/cp-5069-79781-113.html>

七、附件

(略)

主題名稱	頭頸部腫瘤-鼻咽癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K05	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	8/9

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定	98 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
101.08.31	2.1	1. 醫護部改護理部。 2. 說明及護理措施內容部份修辭。	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.1	增修第六項參考資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.2	1. 新增第三項第(一)、(二)目部份定義及症狀之描述。 2. 第三項第(四)目新增常見治療之說明。 3. 第三項第(五)、(六)目新增護理問題-身體心像紊亂，及其護理措施。 4. 第六項參考資料部份增刪及修訂。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	3.3	1. 修訂第三項第一、二、三目參考文獻。 2. 第三項第六目之 2(8)抽吸時間改為不超過 15 秒。 3. 增修第六項參考資料。	107 年 06 月 13 日護理長會議通過
108.09.23	3.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.18	3.5	第三項第六目之 2(17) 抽痰壓力改為 100-120 mmHg。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護理長會議通過;109 年

主題名稱	頭頸部腫瘤-鼻咽癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K05	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	9/9

			08 月 18 日督導會議通過公布。
110.08.05	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.06	3.6	1. 第三項第一目、第二目、第四目、第五目及第六目內容部份修辭及刪除內文參考文獻。 2. 第六項新增參考資料。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.08.03	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.08.08	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.08	3.7	1. 第三項第一目、第二目、第三目 1、3、第四目內容新增及部份修辭。 2. 第六項刪除及新增參考資料。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。